



Faculté de médecine de Tunis
Comité de préparation du concours RESIDANAT 2019
Examen blanc
14 Novembre 2019

Épreuve 2

RECOMMANDATIONS

Cette épreuve comporte 100 questions dont :

- 64 Questions à choix multiple (QCM)
- 10 Cas cliniques (36 questions à choix multiple QCM)

Les réponses doivent être portées sur la fiche optique pour questions de cet examen
Bien vérifier le numéro de la question sur votre fiche optique

Bon Courage

CONCOURS DE RESIDANAT BLANC 2019

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE

QCM N°1 :

Quelles sont les situations responsables d'une anémie d'origine centrale :

- A- Anémie mégaloblastique
- B- Drépanocytose homozygote
- C- Erythroblastopénie
- D- Une Leucémie Aiguë
- E- La sphérocytose

Réponse :

QCM N°2 :

Quelles sont les situations cliniques responsables d'anémie d'origine périphérique :

- A- La sphérocytose héréditaire
- B- L'aplasie médullaire
- C- Hémorragie digestive aiguë
- D- Myélome multiple
- E- Anémie hémolytique auto-immune

Réponse :

QCM N°3 :

Une anémie microcytaire est liée à :

- A- Une carence martiale
- B- Une anémie sidéroblastique
- C- Une érythroblastopénie
- D- Une insuffisance rénale chronique
- E- Une β thalassémie majeure

Réponse :

QCM N°4 :

Le(s) élément (s) suivant(s) est (sont) en faveur d'une anémie d'origine carencielle :

- A- Diminution de la CTF
- B- Diminution du Coefficient de saturation
- C- Augmentation de l'hépcidine
- D- Augmentation de l'érythropoïétine
- E- Diminution du récepteur soluble de la transferrine

Réponse :

QCM N°5

Le(s) élément (s) suivant(s) est (sont) en faveur d'une anémie secondaire à une insuffisance rénale chronique terminale :

- A- Une macrocytose isolée
- B- Une diminution du récepteur soluble de la transferrine
- C- Une augmentation de l'hépcidine
- D- Une diminution de l'érythropoïétine
- E- Une pseudo polyglobulie microcytaire

Réponse :

QCM N°6 :

Au cours d'un syndrome thalassémique majeur, on peut observer :

- A- Un ictère à bilirubine directe associé à une microcytose isolée
- B- Une anémie microcytaire associée à un test de coombs direct positif
- C- Une diminution de l'hépcidine
- D- Une anémie microcytaire associée à un ictère à bilirubine indirecte
- E- Une pseudo polyglobulie microcytaire isolée

Réponse :

QCM N°7:

Devant une adénopathie cervicale isolée, l'examen à demander pour confirmer une origine toxoplasmique est :

- A- La ponction ganglionnaire
- B- La biopsie ganglionnaire
- C- La recherche d'anticorps sériques anti-toxoplasmiques
- D- La recherche d'antigènes toxoplasmiques
- E- L'hémogramme

Réponse :.....

QCM N°8 :

Devant une adénopathie cervicale associée à un syndrome mononucléosique, la parasitose à évoquer est :

- A- La toxoplasmose
- B- La leishmaniose viscérale
- C- Le paludisme
- D- La leishmaniose cutanée
- E- L'hydatidose

Réponse :.....

QCM N°9 :

Au cours de la leishmaniose viscérale, la splénomégalie est associée, sur le plan biologique, à :

- A- Une anémie hémolytique
- B- Une myélémie
- C- Une hyperlymphocytose
- D- Une microcytose
- E- Une leuconeutropénie

Réponse :.....

QCM N°10 :

Devant une splénomégalie fébrile chez un enfant, les éléments orientant vers une leishmaniose viscérale sont:

- A- La consanguinité parentale
- B- L'habitat à Zaghouan
- C- La consommation de lait cru
- D- L'âge inférieur à 5 ans
- E- La consommation d'eau non potable

Réponse :.....

QCM N°11 :

Parmi les accidents transfusionnels suivants, sélectionnez celui ou ceux qui sont tardifs :

- A- L'allo-immunisation Duffy
- B- L'allo-immunisation Rhésus
- C- Le choc endotoxinique
- D- Le purpura post transfusionnel
- E- Surcharge potassique

Réponse :.....

QCM N°12 :

Le test de Coombs indirect est utilisé pour :

- A- La recherche d'anticorps irréguliers
- B- Le phénotypage étendu
- C- La mise en évidence de sensibilisation in vivo des globules rouges
- D- La recherche d'anticorps dans le sérum maternel
- E- La recherche d'anticorps anti chlamydiae

Réponse :.....

QCM N°13 :

Pour prévenir la récurrence d'une réaction de type frisson hyperthermie ; on prescrit un CGR :

- A- Phénotypé
- B- Déleucocyté
- C- Irradié
- D- Filtré
- E- Déplasmatisé

Réponse :.....

QCM N° 14 :

Devant la suspicion d'un purpura post transfusionnel :

- A- On indique la transfusion de plaquettes
- B- On indique la transfusion de plasma frais congelé
- C- On déclare l'accident
- D- On indique la recherche d'anticorps anti HPA-1a
- E- La prévention repose sur la transfusion de plaquettes irradiées

Réponse :.....

QCM N° 15 :

Le purpura vasculaire est souvent :

- A- Monomorphe
- B- Non infiltré
- C- Déclive
- D- Accompagné de syndrome hémorragique
- E- Cutané

Réponse :.....

QCM N°16 :

Le PTT « purpura thrombotique thrombocytopenique » :

- A- Est une macro-angiopathie
- B- Est lié à un excès de l'activité de l'ADAMTS-13
- C- Son diagnostic est évoqué devant la présence de schizocytes sur le frottis sanguin
- D- Est évoqué devant une anémie hémolytique avec TCD positif
- E- Dans sa forme acquise, il est souvent lié à la présence d'auto-anticorps

Réponse :.....

QCM N°17 :

Concernant la thrombasthénie de Glanzman :

- A- Elle est due à défaut de la GPIb-IX
- B- Elle peut être à l'origine de ménorragies chez la femme
- C- Est souvent associée à une thrombopénie
- D- Le diagnostic est évoqué par l'agrégométrie
- E- Le diagnostic est confirmé par la cytométrie de flux

Réponse :.....

QCM n°18

La mutation en faveur d'une augmentation du nombre des récepteurs LDL au niveau de l'hépatocyte est celle :

- A- Du récepteur LDL
- B- De l'ApoB100
- C- De la lipase acide lysosomale
- D- Activatrice de PCSK9
- E- De l'ApoC II

Réponse :.....

QCM n°19

Une hyper triglycémie isolée est évoquée devant :

- A- Un déficit de la lipase acide lysosomale
- B- Une mutation de l'ApoC II
- C- Une mutation inhibitrice de PCSK9
- D- Une inhibition de la CETP
- E- Une hyper synthèse de l'ApoB100

Réponse :.....

QCM n°20 :

Quel(s) est (sont) les facteurs qui stimulent la sécrétion de H⁺ par le rein :

- A- L'hyperkaliémie
- B- L'augmentation du pH intracellulaire
- C- L'aldostérone
- D- Le facteur atrial natriurétique
- E- L'insuline

Réponse :.....

QCM n°21 :

Parmi les propositions suivantes concernant la réabsorption rénale des bicarbonates régénérés, quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) juste(s) :

- A- Elle est associée à une sécrétion d'ion H⁺
- B- S'effectue par un antiport Na⁺ / HCO₃⁻ apical
- C- Nécessite la transformation de la glutamine en NH₄⁺
- D- Nécessite la réabsorption totale des HCO₃⁻ filtrés
- E- Est stimulée par l'angiotensine II

Réponse :.....

QCM n°22 :

Une femme âgée de 35 ans est hospitalisée pour diarrhée profuse. Sa pression artérielle est à 130/70 mmHg en position couchée et à 90/50 mmHg en position debout. La natrémie est à 125 mmol/l et la créatinine plasmatique est à 90 µmol/l. Dans les urines, la natriurèse est à 12 mmol/l et la kaliurèse est à 38 mmol/l. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) le(les) traitement(s) adapté(s) :

- A- Restriction sodée
- B- Diurétique de l'anse
- C- Soluté de chlorure de sodium 9g/l
- D- Solution de bicarbonate de sodium 14g/l
- E- Soluté de chlorure de sodium 9 g/l + KCL

Réponse :

QCM N°23 :

Au cours de(s) situation(s) suivante(s), une hypokaliémie avec une activité rénine plasmatique élevée peut être observée :

- A- Adénome de Conn
- B- Intoxication à la réglisse
- C- Prise de diurétiques
- D- Sténose de l'artère rénale
- E- Traitement par bêtabloquants

Réponse :

QCM N°24

L'acidose métabolique avec une hyperkaliémie s'observe au cours de :

- A- Vomissements abondants
- B- L'insuffisance rénale chronique terminale
- C- Diarrhée
- D- Une néphropathie diabétique compliquée d'hyporéninisme hypoaldostéronisme
- E- Un traitement par diurétique de l'anse

Réponse :

QCM N°25 :

Chez un patient présentant les résultats biologiques suivants : Natrémie : 130mmol/l, Kaliémie : 6mmol/l, Glycémie : 3mmol/l, natriurèse :70 mmol/l ; quel(s) est (sont) le(les) diagnostic(s) à évoquer :

- A- Diabète insipide central
- B- Syndrome de Conn
- C- Restriction hydrique excessive
- D- Insuffisance surrénale aiguë
- E- Régime sans sel excessif

Réponse :

QCM N°26 :

Dans l'attente d'une hémodialyse, quelle(s) est (sont) la (les) mesure(s) thérapeutique(s) à entreprendre chez un patient présentant une hyperkaliémie sévère (Kaliémie : 7 mmol/l, créatinine :400 Umol/l, HCO₃⁻: 20 mmol/l) avec un œdème pulmonaire aigu et une échographie rénale sans anomalies.

- A- Bicarbonate de sodium isotonique
- B- Sel de calcium en IV
- C- Insulatard associé au sérum glucosé
- D- Furosémide
- E- Kayexalate

Réponse :

QCM N°27 :

Au cours d'une pyélonéphrite aiguë communautaire sans signes de gravité, l'antibiothérapie de 1^{ère} intention peut être :

- A- Une céphalosporine de 3^{ème} génération injectable
- B- Une aminopénicilline
- C- Un sulfamide (triméthoprim-sulfaméthoxazole)
- D- Un aminoside après avoir éliminé une contre-indication
- E- Une céphalosporine de 3^{ème} génération par voie orale

Réponse :.....

QCM N°28 :

Pour retenir le diagnostic d'une infection urinaire, le seuil de bactériurie :

- A- Varie en fonction des catégories de germes
- B- Est le même pour les 2 sexes
- C- Varie en fonction du mode de recueil des urines
- D- Est de 10⁴ UFC pour *E.coli*
- E- Est le même chez l'homme quelque soit le germe en cause

Réponse :.....

QCM N°29 :

Parmi les facteurs de risque d'infection urinaire à entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE), vous retenir :

- A- Une prise récente d'aminosides
- B- Une prise récente de céphalosporine de 2^{ème} génération
- C- Une colonisation connue par un germe BLSE
- D- Le sexe féminin
- E- La présence d'une sonde à demeure

Réponse :.....

QCM N°30 :

Parmi les facteurs favorisant les infections urinaires, vous retenir :

- A- La diarrhée
- B- Le sens de la toilette d'avant en arrière
- C- Les atteintes fonctionnelles et/ou organiques de l'appareil urinaire
- D- La ménopause
- E- L'utilisation fréquente d'antiseptiques génitaux

Réponse :.....

QCM N°31

Parmi les antibiotiques qui diffusent le mieux au niveau du parenchyme prostatique, vous retenir :

- A- Les aminosides
- B- Le triméthoprim-sulfaméthoxazole
- C- Les céphalosporines de 2^{ème} génération
- D- Les fluoroquinolones
- E- Les amino-pénicillines

Réponse :.....

QCM N°32 :

Mr HA est hospitalisé pour une insuffisance rénale aigue. Vous avez éliminé une insuffisance rénale aigue obstructive et une insuffisance rénale aigue fonctionnelle. Parmi les syndromes néphrologiques suivants, lesquelles peuvent être à l'origine de l'insuffisance rénale aigue organique sachant que le patient une hématurie à +++ à la bandelette urinaire.

- A- Nécrose tubulaire aigue
- B- Néphropathie glomérulaire aigue
- C- Néphrite immun allergique
- D- Néphropathie vasculaire aigue
- E- Toutes les propositions sont vraies

Réponse :.....

QCM N°33 :

Concernant la prise en charge d'une insuffisance rénale aigue obstructive, quelles sont les propositions vraies :

- A- En cas d'obstacle sous vésical, on doit effectuer un drainage vésical en 1^{ère} intention
- B- En cas de rétention aigue d'urine secondaire à une prostatite aigue, on peut poser une sonde urinaire
- C- En cas de rétention aiguë d'urine secondaire à une hématurie caillotante, la pose d'un cathéter sus pubien est contre indiquée
- D- En cas de compression urétérale bilatérale, on peut poser deux sondes JJ
- E- En cas de lithiase rénale bilatérale, on doit faire une lithotripsie extra corporelle en urgence afin de permettre la levée de l'obstacle

Réponse :

QCM N°34 :

La filtration glomérulaire :

- A- Seul mécanisme permettant la formation de l'urine définitive
- B- Processus unidirectionnel actif
- C- Se fait majoritairement par diffusion
- D- La convection permet la filtration des molécules de petite taille comme les électrolytes
- E- Est maximale au point d'équilibre des pressions hydrostatiques et oncotiques

Réponse :

QCM N°35 :

Concernant la régulation de la filtration glomérulaire :

- A- L'autorégulation permet de maintenir un débit de filtration glomérulaire stable pour des pressions artérielles dépassant 20 cm Hg
- B- Une hypotension artérielle est associée à une vasoconstriction de l'artériole afférente glomérulaire
- C- L'augmentation de la concentration en NaCl dans le filtrat glomérulaire est responsable d'une vasoconstriction de l'artériole afférente glomérulaire
- D- L'angiotensine II est responsable d'une vasoconstriction de l'artériole afférente glomérulaire
- E- L'autorégulation est prédominante en cas d'hémorragie aiguë

Réponse :

QCM N°36 :

**Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles est ou sont vraie(s)
Des urines colorées non hématuriques peuvent se voir dans les situations suivantes:**

- A. Prise de Betteraves
- B. Prise d'Ethambutol
- C. Hémolyse intra vasculaire
- D. Prise d'AINS
- E. Prise de vitamine B12

Réponse :

QCM N°37 :

Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles est ou sont vraie(s):

L'origine glomérulaire d'une hématurie peut être suspectée devant:

- A. La présence de cylindres hématiques
- B. Une hématurie terminale
- C. Une protéinurie à 3 g/24H
- D. La présence de caillots
- E. Une hématurie initiale

Réponse :

QCM N°38 :

**Parmi les propositions suivantes laquelle ou les quelles est ou sont vraie(s)
Une hématurie microscopique est toujours présente dans les
néphropathies glomérulaires primitives suivantes:**

- A- La lésion Glomérulaire Minime
- B- La Glomérulonéphrite Extra-Membraneuse
- C- La glomérulonéphrite segmentaire et focale à dépôts mésangiaux d'IgA
- D- La glomérulonéphrite membrano-proliférative
- E- La Glomérulonéphrite de type hyalinose segmentaire et focale

Réponse :

QCM N°39 :

**Devant une méningite purulente récidivante chez un homme de 24 ans,
quelles sont les étiologies les plus fréquentes ?**

- A. Le déficit en complément
- B. La fracture de la base du crâne
- C. La drépanocytose
- D. L'infection à VIH
- E. La neutropénie

Réponse :

QCM N°40 :

Sur le plan physiopathologique le choc cardiogénique se caractérise par :

- A. Une baisse du débit cardiaque
- B. Un effondrement de la saturation veineuse en O₂
- C. Une hypovolémie
- D. Une atteinte de la membrane alvéolo-capillaire
- E. Des résistances vasculaires périphériques effondrées

Réponse :

QCM N°41 :

La régulation nerveuse du débit cardiaque se caractérise par :

- A. Une double régulation rapide et lente
- B. Une prédominance de la voie sympathique
- C. Une voie parasympathique inhibitrice
- D. Un relais par des barorécepteurs et des chémorécepteurs
- E. Une sécrétion accrue d'acétylcholine en cas de baisse du débit cardiaque

Réponse :.....

QCM N°42 :

En cas d'état de choc cardiogénique :

- A. La pression artérielle diastolique est effondrée
- B. La pression artérielle pulsée est pincée
- C. Des résistances vasculaires périphériques normales
- D. Un débit cardiaque élevé
- E. Une PAPO élevée

Réponse :.....

QCM N°43 :

Quels sont les traitements du choc cardiogénique ?

- A. Antibiotiques
- B. Oxygénothérapie
- C. Assistance circulatoire
- D. Noradrénaline
- E. Dobutamine

Réponse :.....

QCM N° 44:

Quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) correcte(s) concernant le(s) trouble(s) acido-basique(s) :

- A. Le trou anionique urinaire permet d'estimer l'élimination acide sous forme libre
- B. Le trou anionique urinaire positif oriente vers l'origine rénale d'une acidose métabolique par perte primitive de bicarbonate
- C. Le trou anionique urinaire permet de retenir l'origine rénale d'une acidose métabolique avec un Δ Trou anionique plasmatique ($24 - \text{trou anionique calculé}$) = au Δ bicarbonate (bicarbonate mesurée - 12)
- D. Le trou anionique urinaire dépend de l'acidité titrable
- E. Le trou anionique urinaire est calculé selon la formule : $(\text{Na}^+ \text{ urinaire} + \text{Cl}^- \text{ urinaire}) - \text{K}^+ \text{ urinaire}$

Réponse :

QCM N°45 :

Quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) correcte(s) concernant le(s) trouble(s) acidobasique(s):

- A. L'alcalose métabolique chlorosensible est toujours associée à des chiffres tensionnels élevés
- B. L'alcalose métabolique faisant suite à des vomissements est chlororesistante
- C. Une capnie mesurée > à la capnie attendue devant une alcalose métabolique définit l'alcalose mixte
- D. La transfusion massive entraîne, chez un sujet sans antécédents, une alcalose métabolique
- E. L'hypokaliémie est un facteur d'entretien de l'alcalose métabolique

Réponse :

QCM N°46 :

Quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) correcte(s) concernant le(s) trouble(s) acidobasique(s) :

- A. Une intoxication aigue à l'éthanol entraine toujours une acidose métabolique
- B. La validation d'une gazométrie est faite par la comparaison de la PaCO₂ mesurée au taux de CO₂ total sanguin
- C. Des vomissements chroniques s'accompagnent d'une alcalose métabolique par perte de d'acides sulfuriques
- D. L'acidose métabolique peut s'accompagner d'une hypokaliémie
- E. L'hyperchloremie entraine une alcalose métabolique

Réponse :.....

QCM N°47:

Parmi les signes clinique(s) suivant(s), le(s)quel(s) est (sont) compatible(s) avec le diagnostic d'hyperthyroïdie :

- A- Un pincement de la tension artérielle différentielle
- B- Une anorexie
- C- Des troubles du sommeil
- D- Une rétraction de la paupière supérieure
- E- Des troubles des règles chez la femme

Réponse :.....

QCM N° 48:

Parmi les signes biologique(s) suivant(s), le(s)quel(s) est (sont) compatibles avec le diagnostic d'hyperthyroïdie :

- A- Une hypocalcémie
- B- Une hyperglycémie modérée à jeun
- C- Une hypercholestérolémie
- D- Une tendance à l'anémie
- E- Une augmentation minime des transaminases

Réponse :.....

QCM N° 49:

Au cours de la thyroïdite du post-partum :

- A- L'hyperthyroïdie est transitoire
- B- Les anticorps anti-récepteurs de la TSH sont fortement positifs
- C- Le taux de la thyroglobuline est effondré
- D- La scintigraphie montre une hyperfixation diffuse et homogène du radio-isotope
- E- Une récurrence est possible lors des prochaines grossesses

Réponse :

QCM N°50:

A propos des IST en Tunisie, parmi les IST suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) ?

- A- la syphilis est éradiquée en Tunisie
- B- La gonococcie n'est pas une IST à déclaration obligatoire
- C- seulement la syphilis favorise la transmission du VIH
- D- L'incidence des IST est en augmentation.
- E- La trichomonose est une IST fréquente

Réponse :

QCM N°51:

Le(s) IST secondaire(s) à des infections parasitaires est (sont):

- A- Donovanose
- B- Trichomonose
- C- Syphilis
- D- Gonococcie
- E- Chlamydiose

Réponse :

QCM N°52 :

La syphilis est une infection bactérienne, parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) ?

- A- elle est liée à une infection par un spirochète
- B- elle est très contagieuse à sa phase tertiaire
- C- les hommes ayant des relations avec les hommes sont la population la plus à risque
- D- le traitement de 1^{ère} intention est une antibiothérapie orale
- E- Elle fréquemment associée à une gonococcie

Réponse :.....

QCM N°53 :

Parmi les signes cliniques de l'hypothyroïdie périphérique on retient :

- A- La macroglossie
- B- La dépilation axillo-pubienne
- C- L'hypertension artérielle systolique
- D- L'amaigrissement
- E- L'asthénie

Réponse :.....

QCM N°54 :

Les complications cardiovasculaires de l'hypothyroïdie périphérique :

- A- L'hypotension orthostatique
- B- La fibrillation auriculaire
- C- L'insuffisance coronaire
- D- L'endocardite
- E- La péricardite

Réponse :.....

QCM N°55 :

Quels sont parmi ces signes ceux qui vous font évoquer un coma myxoédémateux :

- A. Hypothermie
- B. Signes de Babinski
- C. Hypotension artérielle
- D. Bradycardie
- E. Syndrome d'apnée de Sommeil

Réponse :.....

QCM N°56 :

Au cours de l'hypothyroïdie, on peut observer :

- A. Une hypokaliémie
- B. Une anémie macrocytaire
- C. Une hypernatrémie
- D. Une élévation des enzymes musculaires
- E. Une hyperuricémie

Réponse :.....

QCM N°57 :

Parmi ces situations lesquelles sont responsables d'une hypothyroïdie congénitale transitoire :

- A- Mutation du gène de Récepteur de TSH
- B- Prématuration
- C- Carence iodée
- D- Prise de produits iodés par la mère
- E- Le passage d'anticorps antithyroïdiens maternels

Réponse :.....

QCM N°58 :

La physiopathologie de la Néphropathie Diabétique

- A- Passe par l'augmentation de la filtration glomérulaire
- B- Est expliquée par la stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone
- C- Implique des lésions podocytaires
- D- Est expliquée par une atteinte exclusivement glomérulaire
- E- Passe par une diminution de la pression intra glomérulaire

Réponse :.....

QCM N°59 :

Concernant la néphropathie diabétique

- A. Peut-être la circonstance de découverte du diabète de type 2
- B. La micro-albuminurie est un marqueur de complications vasculaires au cours du diabète de type 2
- C. Se révèle généralement par un syndrome néphrotique
- D. L'HTA apparaît secondairement à l'atteinte rénale au cours du diabète de type 1
- E. La rétinopathie est constamment présente en cas de néphropathie diabétique compliquant un diabète de type 1

Réponse :.....

QCM N°59 :

L'hypoglycémie chez le diabétique :

- A. Se manifeste par des troubles du comportement
- B. Peut-être provoquée par un effort physique
- C. Se voit uniquement chez les patients sous insuline
- D. Nécessite un traitement urgent
- E. N'entraîne pas de troubles de la conscience

Réponse :.....

QCM N°60:

Les bloqueurs du système rénine angiotensine chez le diabétique permettent d'améliorer :

- A. La résistance à l'insuline
- B. Les chiffres tensionnels
- C. La micro-albuminurie
- D. Les signes adrénergiques de l'hypoglycémie
- E. La rétinopathie

Réponse :

QCM N°61:

La base du crâne est formée par les structures osseuses suivantes :

- A- L'os pariétal
- B- L'os Sphénoïdal
- C- L'os maxillaire
- D- L'os occipital
- E- L'os frontal

Réponse :

QCM N°62:

Les foramens au niveau de l'étage postérieur de la base du crane sont :

- A- Foramen Magnum
- B- Foramen Ovale
- C- Canal de l'hypoglosse
- D- Foramen épineux
- E- Foramen Jugulaire

Réponse :

QCM N°63 :

Au décours d'un traumatisme crânien :

- A. L'œdème peut être aussi bien de mécanisme cytotoxique que vasogénique
- B. La contusion hémorragique peut être une lésion évolutive
- C. L'hématome sous dural aigu est localisé entre l'arachnoïde et la pie-mère
- D. L'hématome extradural se traduit radiologiquement par une lame spontanément hyperdense homogène étalée en croissant à limite interne concave.
- E. Les lésions axonales diffuses sont secondaires des lésions de cisaillement des fibres nerveuses

Réponse :.....

QCM N°64 :

Les facteurs d'Aggression Cérébrale Secondaire d'Origine Systémique (ACSOS)

- A. Sont la conséquence des troubles cardiorespiratoires et métaboliques entraînés par le traumatisme
- B. L'hypercapnie entraîne une vasodilatation des vaisseaux cérébraux
- C. La baisse de la concentration en hémoglobine s'accompagne d'une baisse de la Pression intracrânienne
- D. L'hypotension artérielle constitue un des facteurs de risque les plus délétères
- E. L'hydrocéphalie fait partie des ACSOS

Réponse :.....

CONCOURS DE RESIDANAT BLANC 2019

Cas cliniques

Cas Clinique N°1 (Questions N°65,66,67,68 et 69) :

Un patient âgé de 75 ans est hospitalisé en urgence pour confusion aigue. Depuis 6 jours, le patient est asthénique, anorexique mais il continue à boire de l'eau. Le patient est désorienté et il se plaint de vertiges. Il n'a aucune douleur.

Antécédents :

- Diabète type 2 depuis 15 ans
- FA depuis 10 ans
- Infarctus de myocarde il y a 10 ans

Traitements en cours :

Hydrochlorothiazide : 25 mg / jour

Amiodarone : 1 cp / jour

Sintrom : $\frac{3}{4}$ cp / jour

Glibenclamide : 1 cp X 3 / jour

Régime diabétique et sans sel

Sa dernière biologie qui remonte à 1 mois est normale

Examen : PA : 102/62 mmHg (couché) 85/40 mmHg (debout), FC :100 /mn, pli cutané persistant. Absence de déficit sensitif ni moteur.

Biologie : Natrémie : 115 mmol/l, Potassium : 3,2 mmol/l, Chlore : 90 mmol/l, Bicarbonate : 30 mmol/l, Glycémie : 2 mmol/l, Protidémie : 90 g/l, Urée : 25 mmol/l, Créatinine : 160 Umol/l

Urine : Natriurèse : 7mmol/l, Kaliurèse : 18 mmol/l

Échographie rénale sans anomalies

Question N° 65 :

Quelle(s) est (sont) votre (vos) première(s) prescription(s) :

- A. Arrêt du glibenclamide
- B. Injection d'insuline rapide en sous cutané
- C. Injection de 2 ampoules de G30 en intraveineux direct
- D. Perfusion de solution salée isotonique
- E. Arrêt de l'hydrochlorothiazide

Réponse :.....

Question N°66 :

Quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) exacte(s) concernant la fonction rénale :

- A. Il s'agit d'une IRA fonctionnelle
- B. Il s'agit d'une IRA organique
- C. Le taux élevé de HCO_3^- est en faveur de l'IRA organique
- D. Le rapport Na/K urinaire du patient est en faveur de l'IRA fonctionnelle
- E. Cette IRA fait partie du tableau de la déshydratation extra cellulaire présentée par le patient

Réponse :.....

Question N°67 :

Concernant l'hyponatrémie présentée par le patient, précisez la(les) proposition(s) juste(s) :

- A. Le déficit hydrique est plus important que le déficit sodé
- B. La prise des diurétiques de type thiazide est responsable d'un trouble de dilution des urines qui a favorisé la survenue de l'hyponatrémie
- C. Le diabète est responsable de cette hyponatrémie
- D. Le régime sans sel au long cours a favorisé la survenue de l'hyponatrémie
- E. Le maintien d'un apport hydrique malgré l'anorexie a favorisé la survenue de l'hyponatrémie

Réponse :.....

Question N°68 :

Vous avez retenu chez le patient le diagnostic d'une hyponatrémie avec déshydratation extracellulaire. Vous avez prescrit du soluté salé isotonique. Quelle(s) est (sont) le (les) principe(s) thérapeutique(s) que vous allez appliquer ?

- A. Le déficit sodé en mmoles peut être quantifié par la formule suivante :
$$(20\% \times \text{poids actuel}) \times ((\text{Hématocrite actuelle} / 0,45) - 1)$$
- B. Il faut corriger la natrémie au maximum à la vitesse de 5 mmol/l par heure
- C. Il faut surveiller la natrémie toutes les 8 heures
- D. Il faut reprendre une alimentation normosodée dès la disparition de la confusion
- E. La normalisation du secteur extracellulaire freine l'ADH et permet d'éliminer l'excès d'eau

Réponse :

Question N°69 :

Comment aurait-on pu éviter cette complication métabolique chez ce patient âgé :

- A. Ne pas prescrire des diurétiques thiazidiques aux sujets de plus de 75 ans
- B. Ne pas restreindre les apports en sel
- C. Ne pas associé un glibenclamide et un hydrochlorothiazide
- D. Arrêt momentané des diurétiques en cas de cause de déshydratation surajoutée
- E. Effectuer une surveillance biologique régulière chez les sujets âgés à risque

Réponse :

Cas Clinique N°2 (Questions N°70,71,72 et 73) :

Une jeune fille de 22 ans, sans antécédents pathologiques notables, consulte pour brulures mictionnelles, pollakiurie et dysurie évoluant depuis 3 jours.

A l'examen, elle est apyrétique, en bon état général, abdomen souple dépressible, indolore et pas de douleur à l'ébranlement lombaire.

Il est à noter que c'est la 3^{ème} fois qu'elle consulte avec les mêmes symptômes ces 5 derniers mois.

Question N°70 :

La forme clinique que présente cette patiente correspond à

- A-** Une cystite aigue simple
- B-** Une cystite aigue à risque de complication
- C-** Une bactériurie asymptomatique
- D-** Une colique néphrétique
- E-** Une cystite récidivante

Réponse :.....

Question N°71 :

La prise en charge de cette patiente nécessite

- A-** Une antibiothérapie curative
- B-** Des conseils hygiéno-diététiques
- C-** Une échographie abdomino-pelvienne en urgence
- D-** Une antibioprophylaxie systématique
- E-** Un traitement prophylactique non antibiotique

Réponse :.....

Question N°72 :

Parmi les mesures hygiéno-diététiques, vous recommandez

- A-** Une hygiène intime quotidienne par un antiseptique
- B-** Des boissons abondantes
- C-** Une régularisation du transit intestinal
- D-** Le port de vêtements en coton et ample
- E-** L'utilisation de spermicides

Réponse :.....

Question N°73 :

Le traitement ne pouvant être différé car la patiente est très gênée, quelle antibiothérapie de 1^{ère} intention prescrivez-vous ? (une ou plusieurs propositions sont justes)

- A-** Une fluoroquinolone
- B-** Une céphalosporine de 3^{ème} génération orale
- C-** Fosfomycine-trométamol
- D-** Pevmicillinam
- E-** Amoxicilline

Réponse :.....

Cas Clinique N°3 (Questions N°74,75 et 76) :

Mr PA âgé de 75 ans diabétique type 2 sous Glucophage et Daonil, hypertendu sous Amlor. Il est hospitalisé en urgence en chirurgie pour des douleurs abdominales faisant évoquer une pancréatite aiguë. Il a eu un bilan à son admission : créatinine :80 µmol/l, GB :5400 elts/mm³, Hb :14g/dl , VGM :90, Plaquettes :190000, CRP :25 , calcium :2,34mmol/l, Phosphore :1,25mmol/l, protéinurie de 24h<0,3g/24h. Un scanner abdominal a été réalisé en urgence avec injection de produit de contraste. 48 heures après le scanner le patient a développé des œdèmes des membres inférieurs avec une oligurie. L'examen clinique : PA : 120/70, examen pulmonaire et cardio vasculaire normal, des œdèmes des membres inférieurs

A la Biologie : urée : 25 mmol/l, Créatinine : 300 µmol/l, Na :135 mmol/l, K :4,5 mmol/l, Chlore 97 mmol/l,

Question N°74:

Quelle est l'étiologie la plus probable à cette insuffisance rénale aiguë (IRA)

- A- Nécrose tubulaire aiguë
- B- Néphropathie diabétique
- C- Néphropathie vasculaire
- D- Déshydratation
- E- Néphrite interstitielle aiguë

Réponse :

Question N°75:

Quelles sont les facteurs favorisant cette IRA :

- A- Diabète
- B- L'injection du produit de contraste
- C- HTA
- D- Age
- E- Glucophage

Réponse :

Question N°76:

Quelle est votre conduite thérapeutique

- A- Inhibiteur de la pompe à protons (IPP)
- B- Diurétique de l'anse
- C- Diurétique thiazidique
- D- Corticothérapie
- E- Hémodialyse en urgence

Réponse :

Cas Clinique N°4 (Questions N°77,78 et 79) :

Un jeune de 10 ans présente, 15 jours après une angine, une hématurie macroscopique.

A l'Examen physique : Présence d'œdèmes des membres inférieurs
Pression artérielle : 160/100 mmHg
Protéinurie à 2 croix, hématurie à 3 croix à l'examen des urines à la bandelette réactive

A la biologie : Créatininémie 160µmol/l

Question N°77 :

Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles est ou sont vraie(s):

Quels sont, chez ce patient, les éléments qui vous permettent d'évoquer une origine glomérulaire de l'hématurie ?

- A. Age
- B. L'angine
- C. La présence d'une hypertension artérielle
- D. La présence d'une protéinurie
- E. La présence d'une insuffisance rénale

Réponse :.....

Question N°78 :

Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles est ou sont vraie(s):

Le diagnostic le plus probable est:

- A. Une glomérulonéphrite mésangiale à dépôts d'IgA
- B. Une infection urinaire
- C. Un reflux vésico-urétéral
- D. Une glomérulonéphrite aigue post-streptococcique
- E. Une glomérulonéphrite membrano-proliférative

Réponse :.....

Question N°79:

Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles est ou sont vraie(s):

Une ponction biopsie rénale peut être envisagée devant :

- A. La normalisation du complément à 3 mois
- B. La persistance d'une anurie > 5 jours
- C. La persistance d'une hématurie macroscopique > 1 mois
- D. La persistance d'une protéinurie au-delà de 6 mois
- E. La persistance d'un syndrome néphrotique > 10 jours

Réponse :.....

Cas clinique N°5 (Questions 80,81et 82)

Un sujet âgé de 76 ans, alcoolique, présente au mois de janvier une diarrhée et des douleurs abdominales dans un contexte fébrile. Trois jours après, il présente une céphalée, une diplopie, une rétention d'urines et une paralysie faciale.

L'examen note une fièvre à 39°C, une atteinte du III, du VII, un syndrome méningé, une vivacité des réflexes et un globe vésical.

Question°80 :

Devant ce tableau, vous évoquez en premier lieu

- A. une méningo-encéphalite à *Listeria*
- B. une méningo-encéphalite herpétique
- C. une méningo-encéphalite à Virus West Nile
- D. une méningo-encéphalite à pneumocoque
- E. une méningo-encéphalite à *Haemophilus influenzae*

Réponse :.....

Question N°81:

Quels examens complémentaires demandez-vous pour confirmer votre suspicion

- A. ponction lombaire
- B. hémoculture
- C. coproculture
- D. IRM cérébrale
- E. TDM cérébrale

Réponse :

La ponction lombaire montre un liquide clair comprenant 320 cellules/ μ l (60% PNN, 40% lymphocytes), albuminorrachie à 0,9 g/l et glucorrachie à 1 mmol/l (glycémie à 6 mmol/l).

Vous pratiquez une IRM cérébrale et vous trouvez des micro-abcès cérébelleux et du tronc cérébral.

Question N°82 :

Quel traitement débutez-vous dans l'attente de la microbiologie?

- A. Ampicilline 200 mg/kg/j
- B. Ampicilline 200 mg/kg/j + gentamicine 5 mg/kg/j
- C. Cefotaxime 200 mg/kg/j + dexaméthasone 0,6 mg/kg/j
- D. Ceftriaxone 75 mg/kg/j
- E. Amoxicilline 100 mg/kg/j + gentamicine 3 mg/kg/j

Réponse :

Cas clinique N°6 (Questions 83,84 et 85)

Mr M. A âgé de 35 ans, victime d'une brûlure thermique par flammes dans son appartement incendié, est amené aux urgences par les sapeurs pompiers à H3 post brûlures.

A votre arrivée, le patient est conscient et agité.

Ses constantes sont : PA : 100/50mmHg, FC : 120 bpm, SpO2 en air ambiant 92%.

Présence de brûlures de 2ème degré profond de la tête- cou, de la face antérieure du tronc et des brûlures de 3ème degré du membre inférieur gauche circulaire.

Question N°83 :

Selon la règle des 9 de Wallace, la surface corporelle brûlée est évaluée à:

- A. 45%**
- B. 25%**
- C. 50%.**
- B. 36%**
- C. 27%**

Réponse :.....

Question N°84 :

L'unité de Brûlure Standard chez ce patient est évaluée à:

- A. 45%**
- B. 25%**
- C. 99%.**
- B. 54%**
- E. 30%**

Réponse :.....

Question N°85 :

Le patient s'aggrave rapidement avec une PA: 85/55mmHg, FC: 135 bpm, SpO2 80% en air ambiant.

Quelles premières mesures démarrez-vous immédiatement?

- A. Remplissage vasculaire par sérum glucosé**
- B. Oxygénothérapie par masque à haute concentration**
- C. Antibiothérapie double à large spectre**
- D. Remplissage vasculaire par cristalloïde**
- E. Pose de 2 voies veineuses périphériques**

Réponse :.....

Cas clinique N°7 (Questions 86,87 et 88)

Un patient âgé de 52 ans, sous metformine, est admis en réanimation pour prise en charge d'un état de choc septique.

A l'examen :

- TA = 120/59 mm Hg sous 3 mg/h de noradrénaline et diurèse = 50 cc/3 heures
- Ouverture spontanée des yeux, réponse verbale orientée et il bouge ses membres spontanément sans déficit.
- RR à 32 c/mn avec cyanose, tirage intercostal et sus-sternal
- AP : Râles crépitants aux 2 champs pulmonaires
- Marbrures des genoux
- $\theta = 39,8^{\circ}\text{C}$, froideur cutanée

Biologie :

- Urée=1,98 g/L ; Créatinine=250 $\mu\text{mol/L}$; $\text{Na}^+=136 \text{ mmol/L}$; $\text{K}^+=5,8 \text{ mmol/L}$; $\text{Cl}^-=106 \text{ mmol/L}$
- Lactatémie=12 mmol/L ; $\text{CO}_2\text{T}=13 \text{ mmol/L}$

GDS (air ambiant) : pH=7,29 ; $\text{PaCO}_2=26 \text{ mmHg}$; $\text{PaO}_2=56 \text{ mmHg}$; $\text{HCO}_3^-=12 \text{ mmol/L}$

Rx-thorax a montré une image alvéolaire de la base pulmonaire droite

Le diagnostic retenu était un état de choc septique à point de départ pulmonaire.

Question N°86 :

Quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) correcte(s) concernant le(s) trouble(s) acidobasique(s).

- A. L'acidose métabolique est mixte
- B. L'acidose métabolique est en rapport avec une fuite primitive de bicarbonate
- C. La capnie attendue est proche de la capnie mesurée
- D. Le trou anionique urinaire doit être calculé
- E. La gazométrie est interprétable

Réponse :.....

Question N°87 :

Quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) correcte(s) concernant la lactatémie :

- A. Les lactates expliquent l'acidose métabolique chez ce patient
- B. L'origine de l'hyperlactatémie est due uniquement à l'utilisation de la metformine
- C. L'acidose lactique est définie par une acidose métabolique à trou plasmatique élevé et des lactates > 2 mmol/L
- D. Le trou anionique urinaire permet de déterminer l'origine digestive ou rénale de cette acidose
- E. Les lactates représentent l'un des constituants du trou anionique plasmatique

Réponse :.....

L'évolution du patient était favorable permettant le sevrage de la noradrénaline et de l'oxygénothérapie avec à la biologie :

- Urée=1,2 g/L ; Créatinine=150 μ mol/L ; Na+=139mmol/L ; K+=3,8 mmol/L ; Cl-=116 mmol/L
- Lactatémie=3mmol/L ; CO₂T=19mmol/L

Et aux GDS (air ambiant) : pH=7,29 ; PaCO₂=39 mmHg ; PaO₂=98 mmHg; HCO₃=18 mmol/L

Question N°88 :

Quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) correcte(s) :

- A. Il s'agit d'une acidose métabolique pure (simple)
- B. L'acidose métabolique est secondaire à une expansion volémique par du Ringer lactates
- C. L'acidose métabolique est compensée
- D. Un apport excessif en KCl peut expliquer l'acidose
- E. L'hyperlactatémie explique l'acidose métabolique

Réponse :.....

Cas clinique N°8 (Questions 89,90 et 91)

Patient C âgé de 72 ans, aux antécédents d'ACFA depuis 2 ans sous amiodarone est adressé en endocrinologie pour goitre. Il se plaint depuis 6 mois d'une asthénie avec notion d'amaigrissement non chiffré. A l'examen : goitre multinodulaire, pas d'exophtalmie. A la biologie : TSH inférieure à 0,01 mUI/l et FT4 à 18pmol/l(8-20), Anticorps anti récepteurs de la TSH négatifs. Échographie cervicale : goitre multinodulaire, le plus volumineux nodule mesurant 17 mm.

Question N°89 :

Le profil hormonal du patient correspond à :

- A- Une hyperthyroïdie fruste
- B- Une hyperthyroïdie périphérique franche avérée
- C- Une hyperthyroïdie centrale
- D- Une résistance aux hormones thyroïdiennes
- E- Une euthyroïdie biologique

Réponse :.....

Question N°90 :

Parmi les diagnostics étiologiques suivants, le(s)quel(s) sont compatibles avec ce tableau clinique et paraclinique :

- A- Maladie de Basedow
- B- Surcharge iodée
- C- Goitre multinodulaire toxique
- D- Thyroïdite chronique
- E- Adénome thyroïdienne

Réponse :.....

Question N°91:

Afin d'étayer votre diagnostic étiologique, quel examen paraclinique demander :

- A- Dosage des anticorps anti thyroperoxydase (ATPO)
- B- Dosage des anticorps antithyroglobulines (ATg)
- C- Dosage de la thyroglobuline
- D- Scintigraphie thyroïdienne
- E- IRM hypothalamo-hypophysaire

Réponse :.....

Cas clinique N°9 (Questions 92,93,94 et 95)

Un homme de 24 ans consulte pour une baisse de l'acuité visuelle évoluant depuis 17 jours. Il est célibataire, homosexuel à partenaires multiples et sans antécédents pathologiques. Deux mois auparavant, il a présenté une ulcération génitale douloureuse qui a régressée spontanément. Le patient est apyrétique, il présente une éruption maculeuse du tronc et palmo-plantaire non prurigineuse. L'examen neurologique est normal. L'examen ophtalmologique trouve une uvéite antérieure.

Question N°92 :

Devant ce tableau, les diagnostics à évoquer sont :

- A- Un herpès génital
- B- Une syphilis tertiaire
- C- Une syphilis secondaire avec une atteinte neurologique
- D- Une syphilis primaire
- E- Une vascularite oculaire avec des manifestations cutanées

Réponse :.....

Question N°93:

Les facteurs de risque en faveur d'une infection sexuellement transmissible sont :

- A- L'âge
- B- Homosexualité
- C- Partenaires multiples
- D- La prise de corticoïdes
- E- antécédents d'ulcération génitale

Réponse :.....

Question N°94 :

Quel (s) examen (s) demandez-vous pour confirmer le diagnostic le plus probable ?

- A- Sérologie Syphilis (TPHA et VDRL) dans le sang seulement
- B- PCR syphilis dans le sang
- C- Sérologie syphilis (TPHA et VDRL) dans le sang et LCR
- D- Biopsie cutanée d'une macule avec étude bactériologique
- E- Sérologie Herpes virus

Réponse :.....

Question N°95 :

Le traitement de la neurosyphilis est basé:

- A- trois doses d'extencilline à 1 semaine d'intervalle
- B- La doxycycline à 200 mg/j durant 14 jours
- C- Pénicilline G 20 millions /j en IV durant 14 jours
- D- Ceftriaxone 2 g/j durant 10 jours
- E- Fluoroquinolones durant 7 jours

Réponse :.....

Cas clinique N°10 (Questions 96,97,98,99 et 100)

Madame T., âgée de 29 ans, a pris 4 kg en un an. Elle vous consulte en raison d'une perte de cheveux et de la découverte fortuite, à l'autopalpation cervicale, d'un nodule thyroïdien. Elle se plaint d'une fatigue et présenterait depuis quelques mois une constipation inhabituelle. Elle a des antécédents d'un vitiligo et un diabète de type 1 depuis 12 ans. Elle est traitée par un IEC pour une HTA à prédominance diastolique. Elle est également traitée par statines pour une dyslipidémie.

À l'examen cervical, un goitre hétérogène multinodulaire.

L'examen clinique révèle en outre une xérodermie et une dépilation de la queue des sourcils.

Une hypothyroïdie a été suspectée

Question N°96 :

Quels sont les symptômes qui vont vous orienter vers une hypothyroïdie ?

- A- Asthénie
- B- Nodule thyroïdien
- C- HTA à prédominance diastolique
- D- Troubles des phanères
- E- Constipation

Réponse :.....

Question N°97 :

Quel(s) examen(s) biologique(s) demandez-vous en première intention ?

- A- FT3
- B- TSH
- C- Ac anti RTSH
- D- Thyroglobuline
- E- Anticorps anti-thyroglobuline

Réponse :.....

Question N°98 :

Quel(s) examen(s) non biologique(s) demandez-vous en première intention ?

- A- Examen ophtalmologique
- B- IRM hypophysaire
- C- Echographie thyroïdienne
- D- Scintigraphie thyroïdienne
- E- Scanner cervical

Réponse :.....

Question N°99 :

Quel(s) diagnostic(s) étiologique(s) suspectez-vous ?

- A- Une maladie de Basedow
- B- Une thyroïdite de Hashimoto
- C- Une thyroïdite de De Quervain
- D- Une thyroïdite aiguë
- E- Un cancer anaplasique de la thyroïde

Réponse :.....

Question N°100 :

Quel(s) examen(s) biologique(s) va (vont) vous permettre confirmer votre diagnostic ?

- A- dosage des anticorps anti-thyroperoxydase (anti-TPO) à des taux élevés
- B- dosage des anticorps anti-récepteurs de la TSH à des taux élevés
- C- VS accélérée
- D- CRP augmentée
- E- présence d'anticorps antinucléaires

Réponse :.....

Fin de l'épreuve